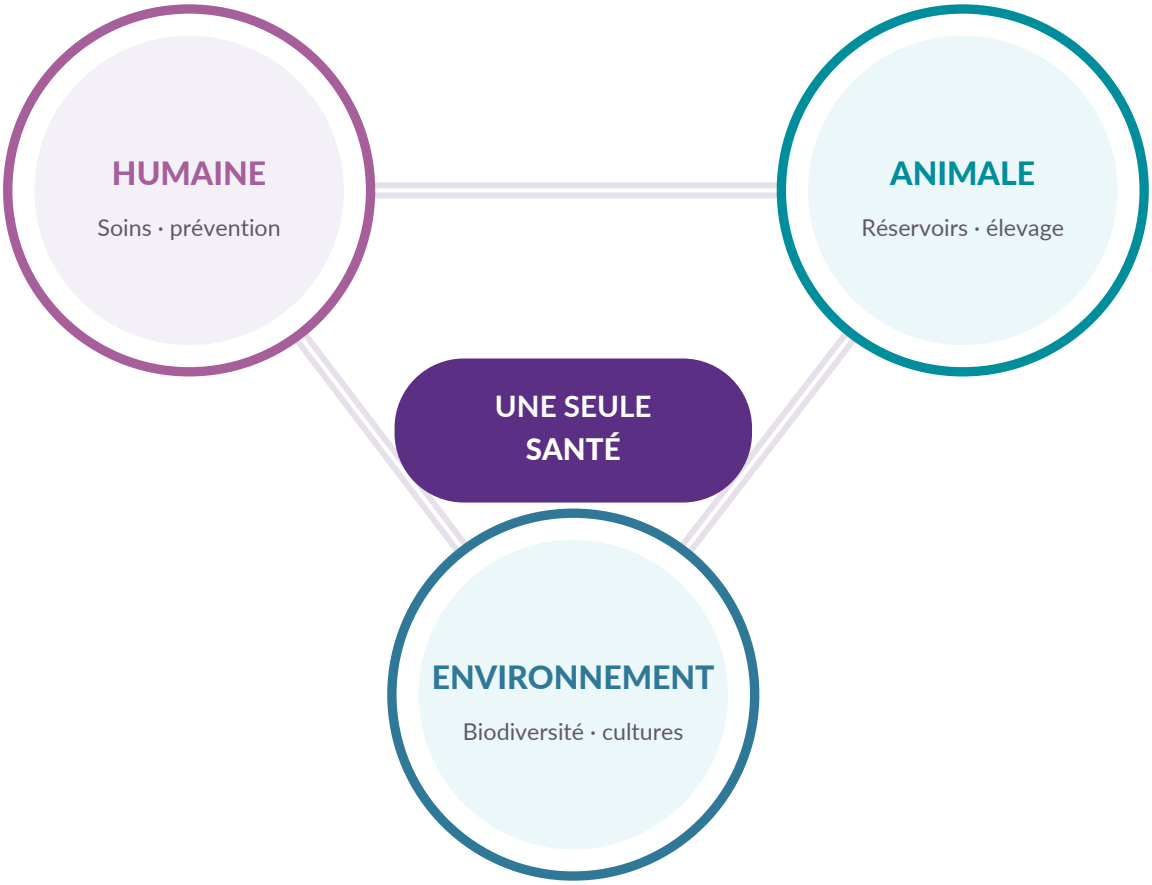
SANTÉ MONDIALE ET SANTÉ EN FRANCE

FICHE HYBRIDE · 21 PAGES · S1

ONE HEALTH

La santé humaine, animale et environnementale est liée.



QUATRE REPÈRES DU VISUEL DE COURS (DIAPO 15)

60 %	**Infections humaines** d'origine animale
20 %	**Pertes de production** animale
75 %	**Espèces cultivées** requérant des pollinisateurs
40 %	**Pertes de cultures** par maladies/ravageurs

Sommaire en page 2 · 19 rubriques · priorités selon le support officiel.

SOMMAIRE

Les 19 rubriques annoncées en page de garde, avec leur page de départ.

COMPRENDRE ET MESURER

01 Santé, santé publique et santé mondiale 3

02 OMD, ODD et pauvreté 4

03 Mesurer la santé : les indicateurs 4

04 Natalité, décès et variation des populations 5

05 Espérance de vie et pyramide des âges 6

06 Mortalité maternelle 6

07 Mortalité néonatale et infantile 7

08 Prévalence, incidence et personnes-temps 9

TRANSITION ET VIH

09 Transition épidémiologique 9

10 VIH et sida 10

MALADIES ET PRÉVENTION

11 Paludisme, tuberculose et émergences 11

12 Maladies cardiovasculaires et respiratoires 11

13 Cancers : incidence, mortalité et survie 13

14 Dépistage organisé et individuel 13

FRANCE ET INÉGALITÉS

15 Grandes causes de décès en France 15

16 Inégalités de santé : ce qui est effectivement sourcé 17

POUR RÉVISER

17 Pièges QCM — confusions à éviter 18

18 Synthèse générale — l'essentiel du cours 19

19 Définitions et mots-clés 20

REPÈRES VISUELS DU SUPPORT OFFICIEL

Mortalité maternelle · p. 8

Cardiovasculaire · p. 12

Cancers : incidence · p. 14

Causes de décès · p. 16

01 Santé, santé publique et santé mondiale

Définition OMS : diapositive visuellement mise en évidence par l'enseignant.

L'**OMS** définit en 1946 la santé par le bien-être **physique, mental et social**, et non par la seule absence de maladie. Cette définition invite à considérer les conditions de vie, les environnements et les ressources des personnes.

La **santé publique** cherche à prévenir les maladies, surveiller les risques et améliorer la santé d'une population. La **santé mondiale** s'intéresse aux enjeux transfrontaliers : infections, ressources, inégalités, environnement et coopération entre pays. L'OMS coordonne et oriente, sans se substituer aux systèmes nationaux.

One Health (« Une seule santé ») relie les santés humaine et animale aux écosystèmes. Une zoonose, une maladie vectorielle ou l'antibiorésistance ne peut pas être étudiée uniquement dans un cabinet médical : les acteurs de terrain, vétérinaires et environnementaux sont également utiles.

Schéma « Santé globale » (diapo 16, source citée dans le support) : la démarche relie les **personnes** (déterminants sociaux et systèmes de santé), la **planète** (mondialisation et santé des écosystèmes), les **priorités** (données probantes, collaboration internationale) et les **politiques/pratiques** (partenariats et interventions). Ces quatre axes sont présentés comme un cadre d'action pour la « santé pour tous ».



Illustrations chiffrées de la diapo 15, à replacer dans leur source : 60 % des maladies infectieuses humaines y sont indiquées d'origine animale ; les maladies animales représentent 20 % de pertes de production animale ; 75 % des espèces végétales cultivées ont besoin de pollinisateurs ; 40 % des pertes de cultures vivrières y sont attribuées aux maladies/ravageurs. **Ce sont les ordres de grandeur du visuel de cours, non des données contrôlées en 2026.**

Notion	Question fondamentale
Soin individuel	Comment protéger et soigner cette personne ?
Santé publique	Comment prévenir et réduire les risques dans une population ?
Santé mondiale	Comment traiter des risques et déterminants dépassant les frontières ?
One Health	Comment agir ensemble sur humains, animaux et milieux ?

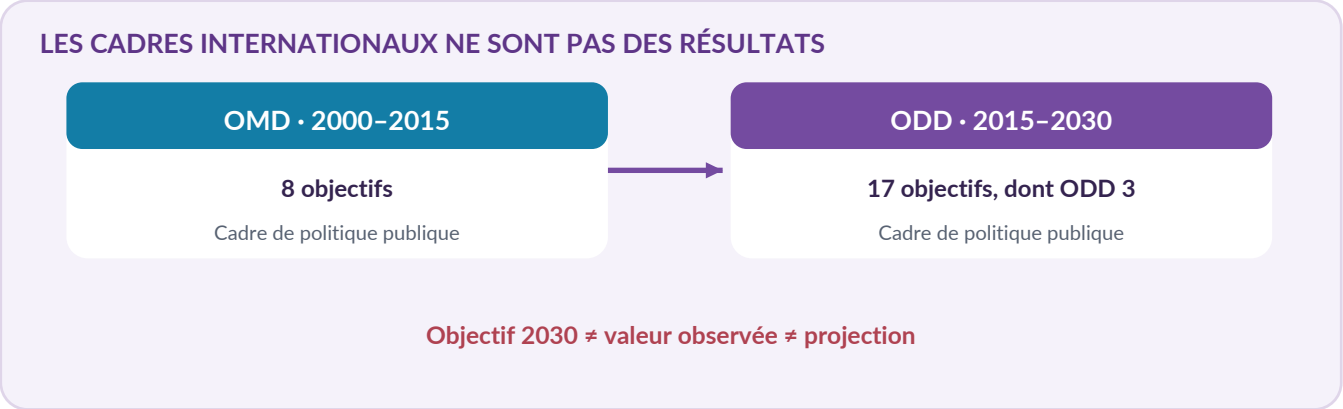
À retenir Une amélioration de la santé mondiale n'efface pas les inégalités entre territoires ni entre groupes sociaux.

02 OMD, ODD et pauvreté

Priorités de cours : objectifs internationaux et interprétation des seuils.

OMD (2000–2015) : huit objectifs, dont réduction de la pauvreté, amélioration de la santé maternelle et infantile et lutte contre les grandes infections. Le cours rappelle des progrès considérables mais inégaux.

ODD (2015–2030) : dix-sept objectifs de développement durable. L'**ODD 3** vise la santé et le bien-être à tous les âges. Certaines cibles sont chiffrées (mortalité maternelle, néonatale, avant cinq ans).



Un **seuil de pauvreté** se comprend uniquement avec sa devise, son unité par personne et par jour, l'année, la méthode et le champ géographique. Le support cite, pour son millésime, environ 9,8 % de la population mondiale sous un seuil de 3 dollars/jour. Une proportion en baisse peut coexister avec un effectif très élevé.

Autres repères du support (diapos 23–25) : environ un quart de la population mondiale vit avec moins de **5 $/jour**, la moitié sous **10 $/jour** et 80 % sous **30 $/jour**, selon les définitions affichées. Une cible présentée pour 2030 mentionne aussi l'éradication de l'extrême pauvreté définie sur cette diapositive par un seuil de **1,25 $/jour** ; **ce seuil ne doit pas être mélangé** avec celui de 3 $/jour utilisé ailleurs dans le cours.

> **À retenir** Une cible annoncée pour 2030 n'est ni un résultat déjà observé ni une prédiction certaine.

03 Mesurer la santé : les indicateurs

Priorité explicite : diapositives à titre blanc sur fond violet consacrées à la mesure.

Un **indicateur** est une mesure résumée permettant de décrire, quantifier, surveiller et comparer l'état de santé d'une population ou d'évaluer une politique publique. Les indicateurs **démographiques** portent sur les naissances, décès, âges et l'espérance de vie. Les indicateurs **épidémiologiques** concernent la fréquence, la distribution ou l'évolution de maladies et facteurs de risque.

INTERPRÉTER UN TAUX : SIX ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES

NUMÉRATEUR	DÉNOMINATEUR	PÉRIODE
Événements comptés	Population à risque	Année, durée

TERRITOIRE	UNITÉ	ÂGE / MÉTHODE
Monde / pays	%, ‰, /100 000	Structure, recueil

Effectifs comparables seulement avec leur contexte

Mesure	Question posée	Unité
Effectif	Combien d'événements ?	Nombre
Proportion	Quelle part de la population ?	%
Taux brut	Combien rapportés à une population sur une durée ?	‰, /100 000
Taux standardisé	Que vaut la comparaison à structure d'âge comparable ?	Selon indicateur

À retenir Ne compare pas directement des taux bruts provenant de populations très différentes par âge sans discuter la standardisation.

04 Natalité, décès et variation des populations

Diapositives 32–41 : distinguer effectifs, taux et populations de référence.

Le **solde naturel** est le nombre de naissances moins le nombre de décès. À l'échelle d'un pays, la variation totale inclut aussi le **solde migratoire**. Une population peut continuer à augmenter alors que son **taux de croissance** diminue.

SOLDE NATUREL · EXEMPLES DU SUPPORT (2023)

MONDE	
Naissances	132 M
Décès	61,7 M
Solde naturel	+ 70,3 M

FRANCE*	
Naissances	639 000
Décès	616 000
Solde naturel	+ 23 000

* Périmètre de la France à vérifier pour comparer les séries

Dans le monde, le support présente environ **132 millions de naissances** et **61,7 millions de décès** pour 2023, soit environ **+70,3 millions** de solde naturel. Pour la France, il affiche environ **639 000 naissances** et **616 000 décès**. Le périmètre exact de ces séries doit être précisé avant toute comparaison.

Taux brut de natalité = naissances vivantes / population de référence × 1 000 ; **taux brut de mortalité** = décès / population de référence × 1 000. Le support (2023) présente **natalité : monde 16,3 ‰ / France 9,6 ‰** ; **mortalité : monde 7,6 ‰ / France 9,3 ‰**. Ces chiffres et les effectifs illustratifs ne proviennent pas nécessairement de séries au périmètre identique : ne pas recalculer un taux en les mélangeant.

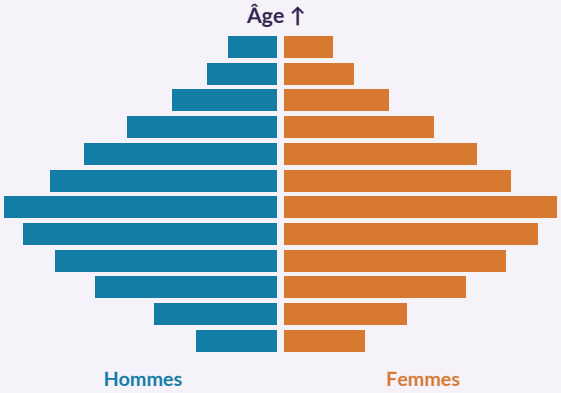
À retenir Le taux de mortalité brut peut être élevé dans une population âgée sans que son système de soins soit moins performant.

05 Espérance de vie et pyramide des âges

L'**espérance de vie à la naissance** est calculée pour une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année étudiée ; elle ne prédit pas le décès d'une personne née cette année-là. L'espérance de vie à un âge donné porte sur les années restantes pour les personnes ayant déjà atteint cet âge.

Les repères de la séance pour la France en 2023 indiquent environ **85,7 ans pour les femmes** et **80,0 ans pour les hommes**. Ces valeurs sont datées ; le cours projette aussi une tendance générale à l'allongement de la vie.

LA POPULATION VIEILLIT : NE PAS CONFONDRE TAUX ET EFFECTIFS



- Base étroite : moins de naissances
- Sommet plus large : survie prolongée
- Taux brut dépend des âges
- Standardiser pour comparer

Une **pyramide des âges** présente la population par âge et sexe. Une base large traduit une natalité importante ; une base plus étroite et des étages supérieurs plus fournis évoquent un vieillissement. Le dessin est volontairement **schématique**, sans données nationales.

À retenir Le vieillissement joue sur les taux bruts. Pour interpréter un écart entre pays, raisonner sur la structure par âge.

06 Mortalité maternelle

Forte priorité : rapport, dénominateur, fenêtre de 42 jours et cible ODD 3.1.

Un **décès maternel** est lié à la grossesse, aggravé par elle ou par sa prise en charge, survenu pendant la grossesse ou **dans les 42 jours** suivant sa fin. Les causes accidentelles ou fortuites sont exclues. Ne pas confondre avec la mortalité néonatale, dont le seuil d'âge est inférieur à 28 jours.

MORTALITÉ MATERNELLE : LE DÉNOMINATEUR CHANGE LE SENS

RAPPORT (RMM)

$$\frac{\text{Décès maternels}}{\text{Naissances vivantes}} \times 100\,000$$

TAUX MATERNEL

$$\frac{\text{Décès maternels}}{\text{Femmes en âge de procréer} \times \text{durée}}$$

Fenêtre : grossesse jusqu'à 42 jours après sa fin

Cible ODD 3.1 : RMM mondial < 70 / 100 000 en 2030

Le **rapport de mortalité maternelle** est exprimé pour 100 000 naissances vivantes. Il ne faut pas le confondre avec le **taux maternel** rapporté aux femmes en âge de procréer et à une durée. Les plus fortes charges décrites se situent notamment dans des pays d'Afrique et d'Asie, en lien avec des inégalités d'accès aux soins obstétricaux et de ressources.

Le support cite pour 2023 environ **260 000 décès maternels dans le monde**, soit environ **712 par jour**. Cela correspond mathématiquement à **un décès toutes les deux minutes**, et non à deux décès par minute. La cible ODD 3.1 pour 2030 est un rapport mondial **inférieur à 70 pour 100 000 naissances vivantes**.

À retenir Repère QCM majeur : 42 jours ; dénominateur du RMM = naissances vivantes ; cible ODD = objectif 2030.

07 Mortalité néonatale et infantile

Néonatale : décès de la naissance au 27e jour révolu, donc **avant 28 jours**. **Infantile** au sens Insee : décès **avant un an**. La mortalité des **moins de cinq ans** couvre une période plus large et ne doit pas être appelée « mortalité infantile » sans préciser la définition de la source.

PÉRIODES DE MORTALITÉ : UNE DIFFÉRENCE DE JOURS COMPTE

NÉONATALE	INFANTILE	AVANT 5 ANS
0–27 jours	avant 1 an	avant 5 ans

Le dénominateur usuel est le nombre de naissances vivantes

Pour les comparaisons internationales, les nombres de décès sont rapportés le plus souvent à **1 000 naissances vivantes**. Le cours donne pour les ODD 2030 les cibles d'au plus **12 décès néonatals pour 1 000** et **25 décès avant cinq ans pour 1 000**. Les cibles ne prouvent pas leur réalisation.

À retenir Ne pas échanger âge du décès maternel (42 jours après la fin de grossesse) et âge de décès néonatal (0–27 jours).

VISUEL ORIGINAL RECONSTITUÉ · DIAPOS 53–54

Mortalité maternelle

Distinguer le rapport, les volumes de décès, les écarts régionaux et l'objectif 2030.

INDICATEUR CLÉ : LE RAPPORT (RMM)

NOMBRE DE DÉCÈS MATERNELS

NOMBRE DE NAISSANCES VIVANTES

× 100 000

Unité : décès / 100 000

REPÈRES CHIFFRÉS DE LA SÉANCE

MONDE · 2023

≈ 200

/100 000 naissances

RMM du support

MONDE · 2023

≈ 260 000

décès maternels

≈ 712 par jour

CIBLE · 2030

< 70

/100 000 naissances

objectif, pas résultat

ÉVOLUTION ET CONTRASTES

2000 → 2023

Baisse du rapport mondial présentée :

– 40 %

Carte du cours

Les niveaux régionaux sont contrastés ; l'Afrique ressort nettement dans la figure. Les écarts ne se résument pas au total mondial.

PIÈGE QCM : VOLUME ≠ RAPPORT

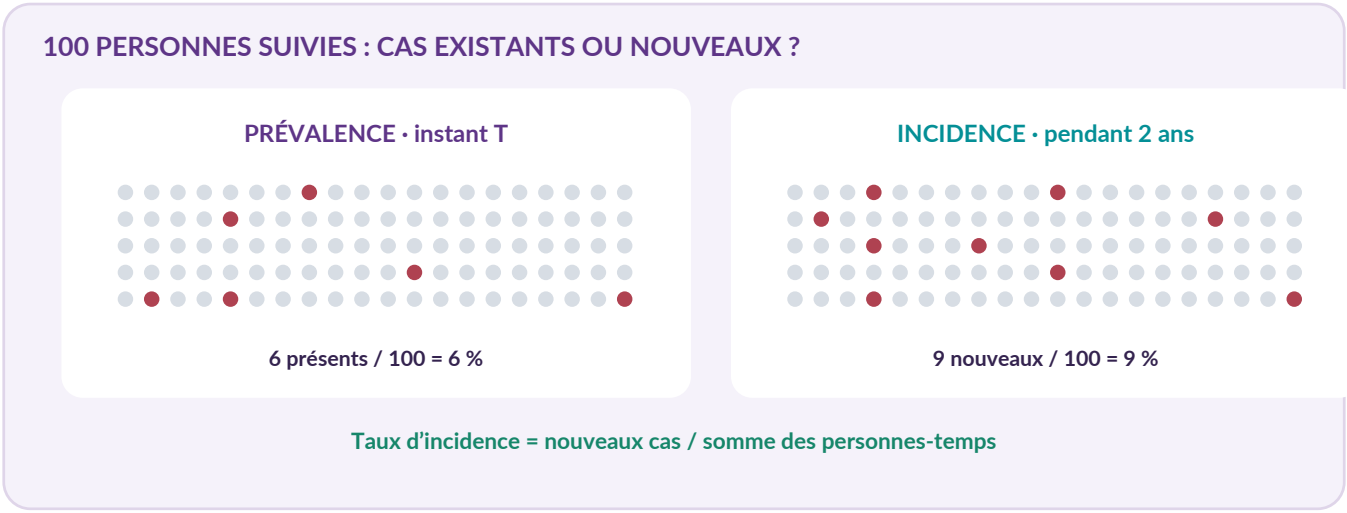
712 décès par jour ≈ un décès toutes les deux minutes ; le support écrit aussi « deux décès/minute », ce qui est incompatible avec le calcul.

Sources internes : diapos 53 et 54 · 20 octobre 2026 · aucun chiffre extérieur ajouté.

08 Prévalence, incidence et personnes-temps

Priorité forte : diapositives 66–78, formule et interprétation.

La **prévalence** mesure la proportion de personnes ayant la maladie **à un instant donné** (ou pendant une période définie). L'**incidence cumulée** mesure la proportion de personnes initialement à risque qui développent la maladie **sur une période**. Le **taux d'incidence** met les nouveaux cas en rapport avec le **temps-personne total de suivi**.



Exemple du cours : 100 personnes suivies pendant deux ans avec neuf nouveaux cas : l'incidence cumulée illustrative est de **9 % sur deux ans** si les 100 personnes étaient initialement à risque et que les conditions de suivi sont celles du schéma. Cela n'implique pas un taux annuel de 4,5 % ni neuf cas par 100 personnes-années sans connaître le suivi réellement cumulé.

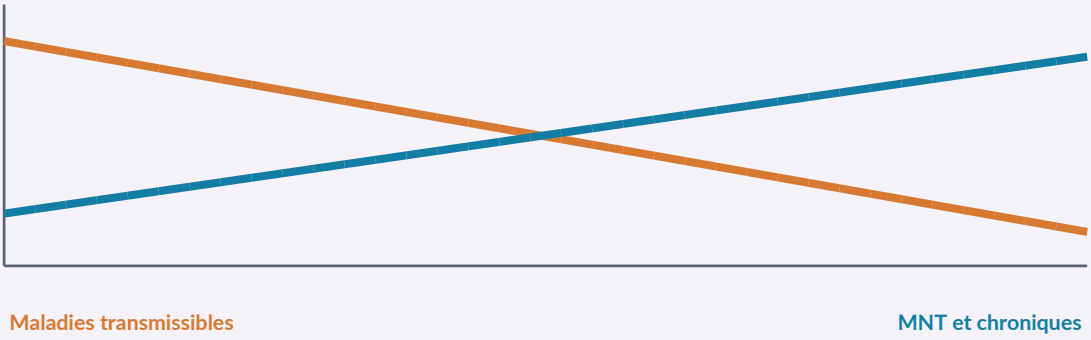
Indicateur	Numérateur	Dénominateur
Prévalence ponctuelle	Tous les cas présents	Population à la date T
Incidence cumulée	Nouveaux cas sur la période	Personnes à risque au départ
Taux d'incidence	Nouveaux cas	Somme des personnes-temps

À retenir Attention : prévalence = stock de cas ; incidence = nouveaux cas ; taux d'incidence = nouveaux cas / temps-personne.

09 Transition épidémiologique

Le cours rappelle la diminution de nombreuses maladies transmissibles sous l'effet combiné de l'assainissement, de meilleures conditions de vie, de la vaccination et des traitements anti-infectieux. La part relative des **maladies non transmissibles** (MNT) augmente, notamment les maladies cardiovasculaires, cancers, diabète et maladies respiratoires chroniques.

TRANSITION ÉPIDÉMIOLOGIQUE : ÉVOLUTION DES CAUSES DE DÉCÈS



Tendances schématiques sans échelle chiffrée

Cette évolution n'est pas identique partout : les régions diffèrent par les déterminants sociaux, l'accès aux soins et l'exposition aux risques. Les maladies transmissibles restent présentes et peuvent réémerger ; les MNT ne sont pas réservées aux pays riches.

Le **taux de létalité** décrit la proportion de malades qui décèdent de la maladie dans une période/une population définie ; il se distingue de la mortalité rapportée à la population générale.

À retenir Une maladie transmissible peut rester très fréquente alors que les MNT représentent la majorité des décès dans une population donnée.

10 VIH et sida

Le **VIH** est le virus de l'immunodéficience humaine, qui compromet notamment la fonction des lymphocytes T CD4. Le **sida** désigne un stade avancé de l'infection, pas un deuxième virus. Les **traitements antirétroviraux (ARV)** empêchent la réplication virale et permettent une prise en charge au long cours, sans constituer une guérison virologique habituelle.

VIH ≠ SIDA : INFECTION, CONTRÔLE ET PRÉVENTION

INFECTION VIH	ARV	CONTRÔLE
Virus et cellules CD4	Blocage de la réplication	Charge virale supprimée

SIDA = stade avancé de l'infection, pas un autre virus

PrEP avant exposition · TPE après exposition

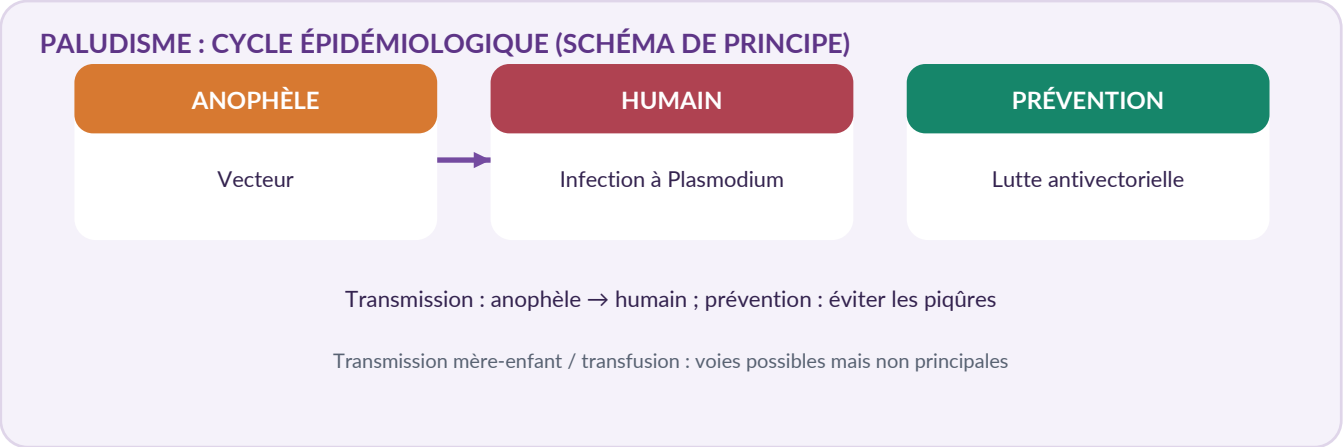
La **PrEP**, prophylaxie avant une exposition à risque, et le **TPE**, traitement post-exposition. Le principe **I = I** concerne l'absence de transmission **sexuelle** du VIH lorsque la charge virale reste durablement indétectable sous traitement efficace ; il ne signifie pas absence de virus dans le corps.

À retenir VIH ≠ sida ; ARV à tous les stades selon indication ; PrEP avant exposition et TPE après exposition.

11 Paludisme, tuberculose et émergences

Paludisme et tuberculose : titres blancs sur fond violet dans le support.

Le **paludisme** est une infection parasitaire due à des *Plasmodium*, notamment *P. falciparum*, transmise principalement par un moustique du genre *Anopheles*. La prévention vise les piqûres, avec mesures vectorielles ; les formes graves nécessitent une prise en charge rapide. Des transmissions mère-enfant ou par transfusion sont possibles mais non principales.



La **tuberculose** est due à *Mycobacterium tuberculosis*. Une infection **latente** est non contagieuse ; une maladie **active pulmonaire** peut transmettre la bactérie par voie aérienne. Le traitement nécessite plusieurs médicaments sur une durée prolongée ; une mauvaise observance favorise les résistances.

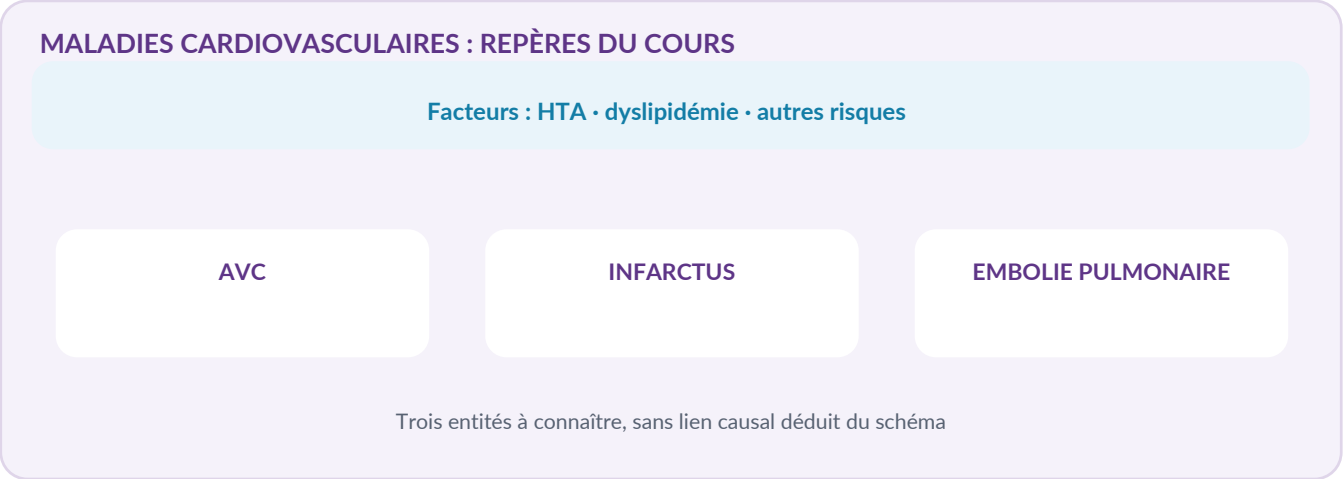
Le cours cite également **Ebola, Zika, chikungunya, grippe aviaire et COVID-19** pour montrer qu'une maladie émergente ou réémergente reste un enjeu de surveillance. Les nombres historiques et létalités indiqués sont dépendants du contexte, de la période et de la définition des cas.

> **À retenir** Ne pas confondre agent (virus, bactérie, parasite), vecteur (moustique), réservoir et mode de transmission.

12 Maladies cardiovasculaires et respiratoires

Synthèse finale explicitement « À retenir » dans le support.

Les maladies cardiovasculaires comprennent notamment **AVC**, **cardiopathies ischémiques** dont infarctus du myocarde, et **maladies thromboemboliques veineuses** dont embolie pulmonaire. L'**HTA** et les dyslipidémies sont des facteurs de risque ; certaines maladies sont également liées entre elles par leurs complications.



VISUEL ORIGINAL RECONSTITUÉ · DIAPO 90

Mortalité cardiovasculaire

Le cours oppose deux cartes : taux de décès rapportés à la population et nombre absolu de décès (2021).

DEUX INDICATEURS QUI NE DISENT PAS LA MÊME CHOSE

TAUX

Décès cardiovasculaires

Population de référence

Variable de la carte de gauche : estimation rapportée à la population.

EFFECTIF

Nombre total de décès cardiovasculaires

2021 · par territoire

Un territoire très peuplé peut avoir un effectif élevé sans avoir le taux le plus élevé.

UNE CLÉ DE LECTURE POUR LES CARTES

Comparer les taux

Dénominateur, période, unité et structure par âge.

Comparer les effectifs

Taille de la population, nombre de décès, année et territoire.

TROIS ENTITÉS CITÉES DANS LA SYNTHÈSE FINALE



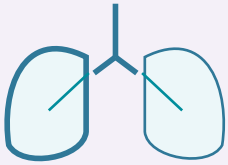
AVC

Accident vasculaire cérébral



INFARCTUS

Du myocarde



EMBOLIE

Pulmonaire

Repères cités par l'enseignant, sans classement entre ces trois affections.

Source interne : diapo 90 et synthèse diapo 100 · données cartographiques non reconstruites.

La dernière diapositive nomme **AVC, infarctus et embolie pulmonaire** comme trois entités à connaître. Cette liste de révision ne doit pas être interprétée comme un classement épidémiologique exhaustif et indépendamment vérifié des causes de décès.

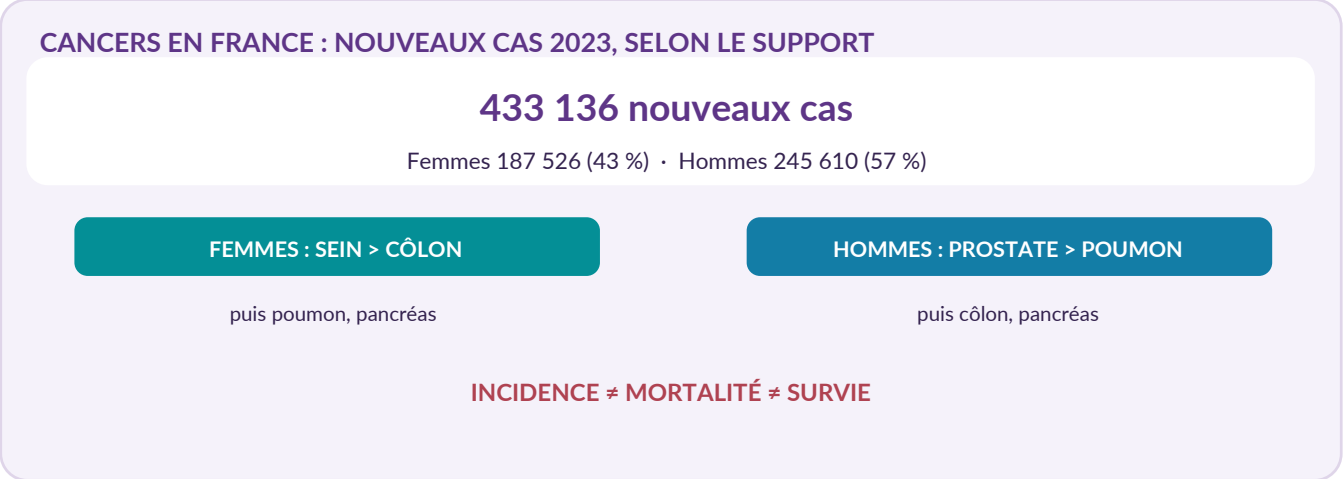
Les maladies respiratoires du cours comprennent **BPCO, asthme, bronchiolite, grippe, pneumonies et tuberculose**. Une maladie fréquente n'est pas nécessairement très létale ; raisonner séparément en **incidence, morbidité et mortalité**.

> **À retenir** Comparer les catégories cardiovasculaires et respiratoires demande d'identifier le mécanisme et le niveau de classification.

13 Cancers : incidence, mortalité et survie

Priorité explicite de la diapositive finale « À retenir » : cinq plus fréquents et cinq plus mortels.

L'**incidence** des cancers décrit les nouveaux diagnostics sur une période. La **mortalité** compte les décès. La **survie nette standardisée** cherche à estimer la survie liée au cancer en tenant compte d'autres causes de décès dans une modélisation spécifique. Ces indicateurs répondent à des questions différentes.



Le support officiel cite environ **433 136 nouveaux cancers en France en 2023**, dont **187 526 chez les femmes** et **245 610 chez les hommes**. Les principales localisations présentées en incidence sont **chez les femmes** : sein (61 214), côlon-rectum (21 370), poumon (19 339), pancréas (7 668) ; **chez les hommes** : prostate (59 885), poumon (33 438), côlon-rectum (26 212), pancréas (8 323). Ces listes sont des extraits des graphiques, pas un classement exhaustif des cinq cancers demandés.

Le support demande d'apprendre les **cinq cancers les plus fréquents et les cinq les plus mortels** ; cependant, ses diapositives accessibles n'énumèrent pas les deux classements complets. La liste « cinq plus mortels » est donc un **point de vérification documentaire**, à ne pas inventer.

> **À retenir** Fréquence ne dit rien, à elle seule, de la gravité ou de la mortalité : un cancer très fréquent n'est pas forcément le plus meurtrier.

14 Dépistage organisé et individuel

Le **dépistage organisé** s'adresse à des groupes cibles définis selon les programmes publics et leurs critères (âge, etc.), avec invitation et parcours organisé. Le **dépistage individuel** est discuté dans le cadre d'une relation clinique en fonction de facteurs de risque personnels, antécédents et symptômes éventuels. Ne pas confondre un dépistage d'une personne asymptomatique et un examen diagnostique motivé par des symptômes.

VISUEL ORIGINAL RECONSTITUÉ · DIAPO 95

Incidence des cancers

Nouveaux diagnostics en France en 2023 : quatre localisations présentées par sexe, sans inventer un « top 5 ».

TOTAL DES NOUVEAUX CAS (2023)

433 136



Femmes : 187 526 · 43 %
Hommes : 245 610 · 57 %

FEMMES · 68 ans (âge médian)

HOMMES · 70 ans (âge médian)

CHEZ LES FEMMES

Nouveaux cas selon les 4 sites affichés

Sein	61 214
Côlon-rectum	21 370
Poumon	19 339
Pancréas	7 668

Mêmes unités · données du cours 2023

CHEZ LES HOMMES

Nouveaux cas selon les 4 sites affichés

Prostate	59 885
Poumon	33 438
Côlon-rectum	26 212
Pancréas	8 323

Mêmes unités · données du cours 2023

ATTENTION : INCIDENCE ≠ MORTALITÉ

La diapositive affiche quatre localisations par sexe. Elle ne permet pas de reconstituer les deux listes nationales complètes demandées dans la diapo 100.

Source interne : diapo 95. Chiffres transcrits du support, sans classement supplémentaire.

DÉPISTAGE : MÊME FINALITÉ, DEUX MODALITÉS

ORGANISÉ	INDIVIDUEL
Population cible invitée	Décision avec le médecin
Critères définis par programme	Facteurs de risque personnels

Dépister n'est pas diagnostiquer une maladie déjà symptomatique

Il faut préciser le **cancer concerné**, la population cible, l'examen, les bénéfices et les limites du programme plutôt que de considérer tout dépistage comme systématiquement nécessaire ou identique pour tous.

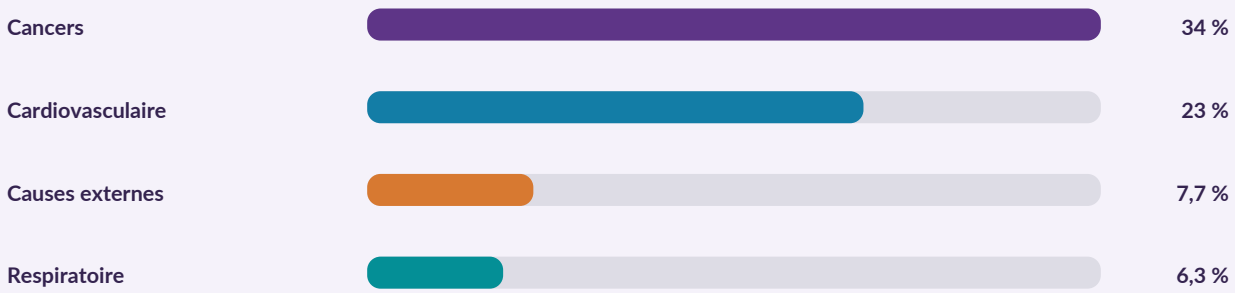
À retenir Deux modalités à distinguer dans les QCM : organisé (cible populationnelle) et individuel (indication clinique personnalisée).

15 Grandes causes de décès en France

La diapositive 100 est une synthèse explicite à retenir.

Le cours présente, pour un millésime annoncé 2023, des valeurs indicatives : cancers **34 % (212 000)**, maladies cardiovasculaires **23 % (147 000)**, causes externes **7,7 % (48 000)**, appareil respiratoire **6,3 % (39 000)**. Ce sont les **valeurs du support**, qui comporte une référence bibliographique à des données d'un autre millésime : ne pas les actualiser ou les fusionner sans contrôler la source d'origine.

GRANDES CAUSES DE DÉCÈS EN FRANCE (CHIFFRES DU SUPPORT)



Périmètre et millésime exacts à vérifier avant toute actualisation

D'après ce support, les **cancers** forment la première grande cause de décès dans l'ensemble des sexes réunis, alors que les maladies cardiovasculaires sont indiquées comme première grande cause chez les femmes. Les catégories exactes, les années de référence et les classifications nécessitent d'être conservées pour interpréter correctement cette distinction.

À retenir Préciser systématiquement « données du cours » et l'année : ce tableau n'est pas un bilan épidémiologique réactualisé en 2026.

VISUEL ORIGINAL RECONSTITUÉ · DIAPO 98

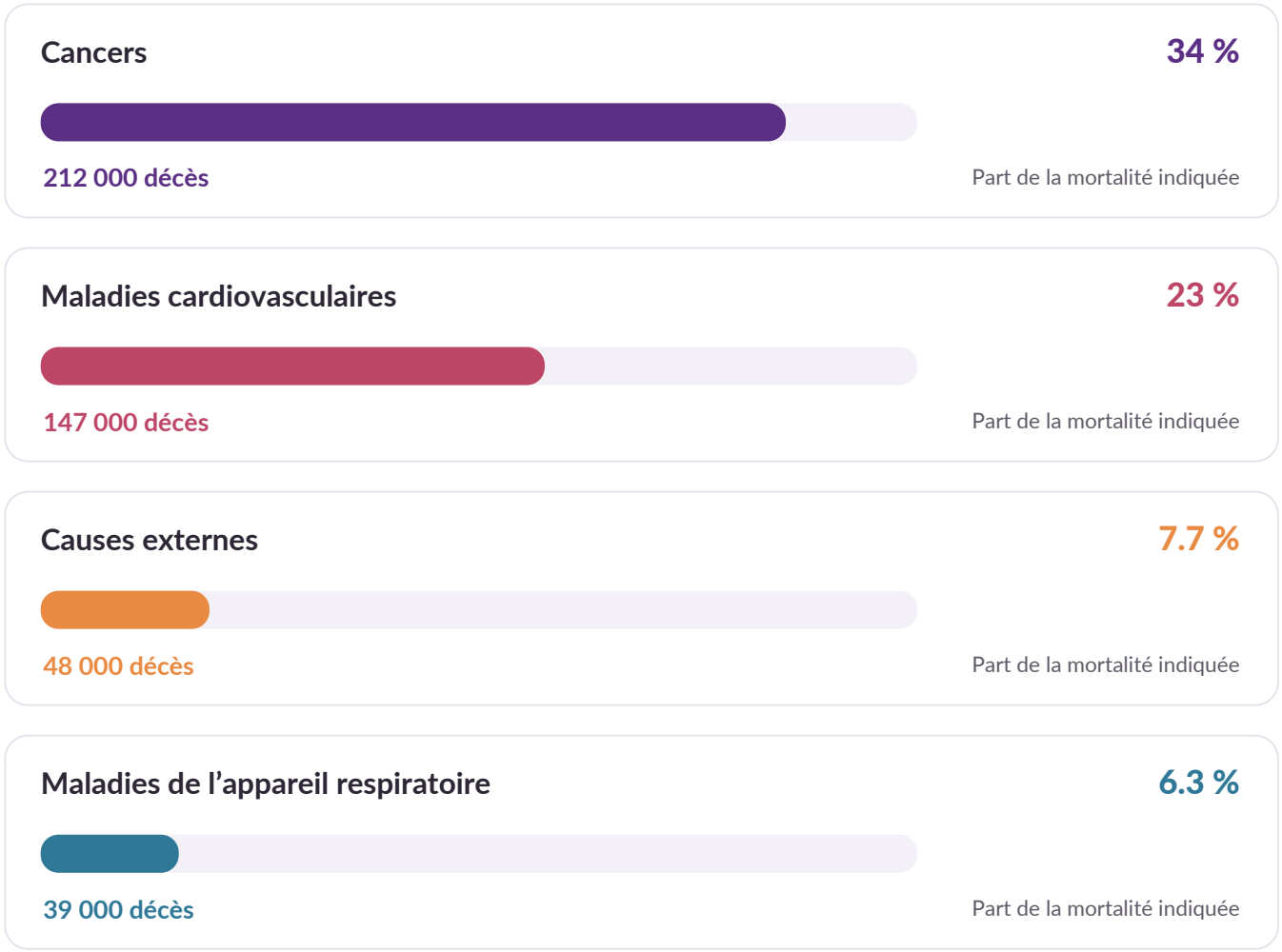
Causes de décès en France

Quatre familles de causes présentées par l'enseignant ; pourcentages et effectifs issus du même support.

DONNÉES AFFICHÉES : 2023

La référence bibliographique citée dans la diapo 98 renvoie à 2021 : le millésime exact des valeurs doit être confirmé.

PROPORTION DES DÉCÈS PAR GRANDE FAMILLE



PRÉCISION DE L'ENSEIGNANT

Le support mentionne les maladies cardiovasculaires comme première cause de décès chez les femmes ; les cancers sont présentés en tête tous sexes confondus.

Source interne : diapo 98 · catégories non exhaustives · année de référence à confirmer.

16 Inégalités de santé : ce qui est effectivement sourcé

Le support présente des **inégalités entre régions et niveaux de revenu** : mortalité maternelle, mortalité des enfants, maladies transmissibles et non transmissibles ne se répartissent pas uniformément. Il rappelle le rôle des ressources, de l'hygiène, du contexte social et de l'organisation de la prévention.

Les **besoins, l'accès aux soins et le recours aux soins** sont annoncés dans le plan et les objectifs, mais ils ne font pas l'objet d'une séquence développée repérable dans les 101 diapositives disponibles. Ils ne sont donc pas détaillés au-delà des mécanismes réellement montrés dans le cours. Un complément de l'enseignant peut être nécessaire pour cette partie.

Risque d'erreur	Réflexe utile
Comparer pays riches et pauvres en valeur absolue	Vérifier population, structure d'âge, année et indicateur
Dire qu'un progrès global signifie égalité	Rechercher les écarts territoriaux ou sociaux
Confondre besoins, accès et recours	Ne pas supposer que toute possibilité de soins entraîne un usage effectif

À retenir Les écarts décrits par le cours sont des constats contextualisés, pas une opposition uniforme entre « Nord » et « Sud ».

17 Pièges QCM — confusions à éviter

Piège	Correction courte
1. Santé ≠ absence de maladie	L'OMS inclut physique, mental et social.
2. ODD ≠ résultat obtenu	Une cible 2030 n'est pas une valeur observée.
3. Effectif ≠ taux	Un plus grand nombre ne signifie pas un risque individuel plus élevé.
4. Taux brut ≠ taux standardisé	La structure par âge peut changer la comparaison.
5. Solde naturel ≠ variation totale	L'immigration et l'émigration interviennent à l'échelle nationale.
6. Espérance de vie ≠ pronostic personnel	C'est une table de mortalité de période sur une génération fictive.
7. Décès maternel ≠ néonatal	42 jours après la fin de grossesse versus 0–27 jours de vie.
8. RMM ≠ taux maternel	Naissances vivantes versus femmes en âge de procréer avec durée.
9. 712 décès/j ≠ 2 décès/min	712 / 1 440 ≈ 0,49/min : environ un toutes les deux minutes.
10. Prévalence ≠ incidence	Cas présents à T versus nouveaux cas sur période.
11. Incidence cumulée ≠ taux d'incidence	Personnes initialement à risque versus personnes-temps.
12. VIH ≠ sida	Virus versus stade avancé de l'infection.
13. Latence TB ≠ tuberculose pulmonaire active	La latence n'est pas contagieuse.
14. Incidence cancer ≠ mortalité	Le classement fréquent n'est pas celui des cancers les plus mortels.
15. Dépistage organisé ≠ individuel	Cible populationnelle versus indication individualisée.
16. Catégories cardiovasculaires ≠ classement exhaustif	AVC, infarctus et embolie sont cités, sans hiérarchie universelle démontrée.

18 Synthèse générale — l'essentiel du cours

Axe	À mémoriser
SANTÉ	Bien-être physique, mental, social ; santé mondiale et One Health sont multifactorielles.
OBJECTIFS	OMD 2000–2015 ; ODD 2015–2030 ; ODD 3 = santé et bien-être.
DÉMOGRAPHIE	Solde naturel = naissances − décès ; ne pas confondre effectifs et taux.
MORTALITÉ	Maternelle 42 jours, RMM /100 000 naissances ; néonatale <28 j, infantile <1 an.
ÉPIDÉMIOLOGIE	Prévalence = cas présents ; incidence = nouveaux cas ; taux d'incidence = personnes-temps.
TRANSITION	Les MNT augmentent en part relative ; les infections persistent et peuvent réémerger.
INFECTIONS	VIH ≠ sida ; paludisme vectoriel ; tuberculose latente non contagieuse.
CANCERS	Incidence, mortalité, survie et dépistage sont des notions distinctes.
FRANCE	Retenir les ordres de grandeur du support avec leur période et leur périmètre.

Méthode finale À l'épreuve : identifier ce qui est compté, chez qui, sur quelle période, avec quel dénominateur et dans quelle unité.

19 Définitions et mots-clés

Définitions utiles à la mémorisation et au rappel actif.

Santé (OMS) — Bien-être physique, mental et social ; pas seulement absence de maladie.

Santé publique — Actions collectives destinées à prévenir, protéger et améliorer la santé de populations.

Santé mondiale — Enjeux et coopérations sanitaires qui traversent les frontières.

One Health — Approche intégrée des santés humaine, animale et environnementale.

Déterminant de santé — Facteur biologique, social, comportemental ou environnemental influençant la santé.

OMS — Organisation mondiale de la santé, agence spécialisée du système des Nations unies.

OMD — Objectifs du Millénaire pour le développement : huit objectifs, 2000–2015.

ODD — Objectifs de développement durable : dix-sept objectifs, 2015–2030.

ODD 3 — Objectif de santé et de bien-être pour tous à tous les âges.

Indicateur de santé — Mesure de description, surveillance, comparaison ou évaluation d'un phénomène de santé.

Indicateur démographique — Mesure de la structure et du renouvellement d'une population.

Indicateur épidémiologique — Mesure de la fréquence ou de la distribution des maladies et des risques.

Numérateur — Nombre d'événements comptés dans un rapport ou taux.

Dénominateur — Population, naissances vivantes ou temps-personne servant de référence.

Solde naturel — Naissances moins décès au cours d'une période.

Solde migratoire — Entrées de population moins sorties sur un territoire.

Taux brut de natalité — Naissances vivantes / population de référence × 1 000.

Taux brut de mortalité — Décès / population de référence × 1 000.

Standardisation par âge — Méthode ajustant les différences de structure d'âge pour comparer des taux.

Espérance de vie à la naissance — Durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux taux de mortalité d'une période.

Décès maternel — Décès dû ou aggravé par la grossesse jusqu'à 42 jours après sa fin, hors cause fortuite.

RMM — Rapport de mortalité maternelle : décès maternels / naissances vivantes × 100 000.

Taux maternel — Décès maternels rapportés aux femmes en âge de procréer sur une durée définie.

Mortalité néonatale — Décès de la naissance avant 28 jours de vie.

Mortalité infantile — Décès avant l'âge d'un an (définition Insee/infant mortality).

Mortalité des moins de cinq ans — Décès survenant avant le cinquième anniversaire.

Morbidité — Fréquence ou conséquences des maladies dans une population.

Mortalité — Décès dans une population, exprimés en nombre ou en taux.

Létalité — Part des personnes atteintes d'une maladie qui en décèdent pendant une période donnée.

Prévalence ponctuelle — Part de la population malade à une date T.

Incidence cumulée — Proportion des sujets à risque développant la maladie pendant une période.

Taux d'incidence — Nouveaux cas rapportés à la somme des personnes-temps à risque.

Personne-temps — Quantité de suivi accumulée par les personnes à risque.

MNT — Maladies non transmissibles, notamment cardiovasculaires, cancers, diabète et maladies respiratoires.

Transition épidémiologique — Évolution de la répartition des causes de morbidité et de décès.

VIH — Virus de l'immunodéficience humaine.

Sida — Syndrome d'immunodéficience acquise ; stade avancé de l'infection VIH.

ARV — Antirétroviraux, médicaments qui inhibent la réplication du VIH.

PrEP — Prophylaxie pré-exposition au VIH.

TPE — Traitement post-exposition au VIH.

I = I — Indétectable = intransmissible sexuellement sous suppression virale durable.

Paludisme — Maladie parasitaire due à Plasmodium, principalement transmise par Anopheles.

Vecteur — Organisme assurant la transmission d'un agent pathogène, par exemple un moustique.

Tuberculose latente — Infection tuberculeuse sans maladie active, non contagieuse.

Tuberculose active — Maladie due à Mycobacterium tuberculosis, pouvant être contagieuse si pulmonaire.

Antibiorésistance — Capacité d'une bactérie à résister à un antibiotique.

HTA — Hypertension artérielle, facteur de risque cardiovasculaire.

AVC — Accident vasculaire cérébral.

Infarctus du myocarde — Nécrose d'une partie du muscle cardiaque par ischémie.

Embolie pulmonaire — Obstruction d'une artère pulmonaire, généralement par thrombus veineux.

Incidence du cancer — Nombre de nouveaux diagnostics de cancer sur une période.

Survie nette — Estimation de survie liée au cancer dans un cadre statistique écartant les autres causes de décès.

Dépistage organisé — Programme visant une population cible selon des modalités définies.

Dépistage individuel — Démarche personnalisée en fonction du contexte et des facteurs de risque.

Accès aux soins — Possibilité d'obtenir des soins adaptés ; concept cité au plan du cours.

Recours aux soins — Utilisation effective de services de santé ; concept cité au plan du cours.